

4 - 04- Les Paralysies Faciales Périphériques - Pr. Raji

Bonjour, je suis professeur Raji, otorhinolaryngologiste et chirurgien cervico-facial. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler dans le cadre des cours de cinquième année des études médicales dans le sous-module de la pathologie ORL des paralysies faciales périphériques. La paralysie faciale périphérique est une pathologie très fréquente devant laquelle le clinicien a un véritable souci de diagnostic étiologique, mais aussi de diagnostic de gravité, de diagnostic topographique.

Alors, pour traiter ce cours, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs. Tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'une paralysie faciale périphérique. On va préciser quels sont les signes cliniques d'une paralysie faciale périphérique.

Vous allez voir que dans ce cadre-là, nous allons voir la paralysie faciale totale et puis la paralysie faciale fruste, etc. Préciser les signes de gravité d'une paralysie faciale périphérique. Établir le diagnostic topographique de l'atteinte lésionnelle au cours d'une paralysie faciale périphérique.

Préciser les diagnostics différentiels d'une paralysie faciale périphérique et on insinue par là essentiellement la paralysie faciale centrale. Établir les diagnostics étiologiques d'une paralysie faciale périphérique. Préciser les principes du traitement d'une paralysie faciale périphérique, en particulier la paralysie faciale idiopathique.

Et enfin, préciser les complications et séquelles d'une paralysie faciale périphérique. Alors, c'est quoi une paralysie faciale périphérique ? C'est une paralysie faciale secondaire à une lésion du nerf facial en avant des noyaux moteurs de celui-ci. C'est-à-dire toute lésion qui va commencer au niveau du deutoneurone, à partir du deutoneurone.

Les étiologies des paralysies faciales périphériques, nous allons le voir, sont très nombreuses. Et ceci est dû au fait que le nerf facial est parmi les nerfs qui ont le trajet le plus long au niveau de différentes régions anatomiques. Deuxièmement, le rôle sécrétoire et le rôle réflexe et sensoriel du nerf facial va nous permettre d'identifier une diversité de tableaux cliniques qui vont nous permettre de rattacher ceci à un siège lésionnel au niveau du nerf facial tout au long de son trajet.

Une connaissance de la neuroanatomie du nerf facial, plus particulièrement le nerf facial moteur, est indispensable pour la compréhension de la paralysie faciale périphérique. La fonction faciale prend naissance au niveau d'un premier neurone qui démarre de l'aire frontale ascendante et qui va faire rejoindre cette aire frontale ascendante au noyau du nerf facial. La particularité de ce premier neurone, c'est qu'il va avoir une distribution bilatérale pour les territoires supérieurs de la face et unilatérale pour les territoires inférieurs de la face.

Ce qui explique que lors de l'atteinte d'une frontale ascendante, c'est-à-dire une atteinte d'origine centrale, l'atteinte des territoires supérieurs est beaucoup moins importante que l'atteinte des

territoires inférieurs qui sera totale. Et c'est la raison pour laquelle au cours de la paralysie faciale d'origine centrale, l'atteinte des territoires inférieurs est prépondérante. Et c'est ce qui fait la grande différence entre la paralysie faciale périphérique et la paralysie faciale centrale.

Le deuxième neurone, qui lui prend naissance à partir du noyau du facial, va avoir un trajet intracranien au niveau de ce qu'on appelle l'angle pontocérébelleux entre le pons et le cervelet. Avant que le nerf pénètre dans la pyramide pétreuse pour décrire un trajet intrapétreux au niveau du canal de Fallop. Et bien sûr, lorsque le nerf va sortir de la pyramide pétreuse au niveau du trou stylo-mastoïdien, le nerf facial va décrire un trajet cervico-facial.

Le nerf facial prend naissance au niveau des aires motrices au niveau de la frontale ascendante. À partir desquelles va partir le premier neurone du nerf facial, aussi bien de la frontale ascendante droite que de la frontale ascendante gauche, pour rejoindre les noyaux du nerf facial. Le motoneurone, lui, qui va partir du noyau du nerf facial, va rejoindre la partie supérieure du nerf facial.

Mais la provenance de la stimulation provient des deux aires corticales. Pour la partie supérieure de la face. Par contre, pour la partie inférieure de la face, celle-ci va tirer son innervation motrice exclusivement de la frontale ascendante contre-latérale par rapport à l'hémiface en question.

Ce qui explique, au cours des paralysies faciales centrales, la persistance d'une innervation des territoires supérieurs et par conséquent l'absence de signes de Charles Bell. Et dans la paralysie faciale totale, l'atteinte des territoires supérieurs et inférieurs. Sur ce schéma-là, on voit l'anatomie du nerf facial intrapétreux où on voit bien sûr la portion labyrinthique entre le vestibule en arrière et le limaçon en avant.

Cette portion labyrinthique va, au niveau du ganglion géniculé, au niveau du genou du facial, se couder en arrière et à l'horizontale pour former la portion tympanique et qui va, au niveau du coude, devenir hors vertical pour former la portion mastoïdienne du nerf facial. Au niveau du ganglion géniculé, on va voir l'émergence des nerfs pétreux. On va voir lorsqu'on va parler de la physiologie du nerf facial et de leur importance sur le plan du diagnostic topographique de la paralysie faciale.

Au niveau de la portion tympanique, il n'y a pas de branche collatérale mais par contre au niveau du segment mastoïdien, on va avoir tout d'abord une première collatérale qui est la branche du muscle de l'étrier et bien sûr une deuxième branche qui est la corde du tympan. Tous ces éléments de l'anatomie sont fondamentaux à connaître pour pouvoir comprendre les éléments du diagnostic topographique des paralysies faciales périphériques. Sur le plan physiologique, le nerf facial est un nerf mixte.

Il comprend des fibres motrices destinées au muscle de l'étrier, au muscle extracranien, en particulier le ventre postérieur du digastrique, au muscle styloïdien et par ses branches

terminales au muscle possédé de la face responsable de la mimique. Les branches sensitives sont responsables de l'innervation de la zone de Ramsey-Hind qui comprend le tragus, la conque, l'antélix et le méa auditif externe et qui vont nous permettre de comprendre ultérieurement comment est-ce qu'on peut avoir une paralysie faciale périphérique au cours d'une atteinte par le zona. Les fibres sensorielles, elles, vont être responsables de l'innervation des territoires gustatifs des deux tiers antérieurs de la langue et qui seront assurés plus particulièrement par la corde du tympan qui va aller rejoindre le nerf lingual et innover les deux tiers antérieurs de la langue.

Les fibres végétatives du nerf facial sont doubles. D'une part, par le nerf facial vont rejoindre le noyau lacrymonasal qui va être responsable de la sécrétion des glandes lacrymales et des sécrétions muqueuses des fosses nasales. Par l'intermédiaire de Weisberg, c'est-à-dire le 7 vis, qui va rejoindre le noyau salivaire supérieur, ils vont être responsables de la sécrétion salivaire des glandes sous-maxillaires et sublinguales.

Sur ce schéma, on voit très bien les éléments de la physiologie du nerf facial. Vous avez à ce niveau-là le tronc cérébral avec les différents noyaux moteurs et les noyaux sensitifs du nerf facial et qui vont donner une émergence de ce nerf au niveau de l'angle pontocérébelleux avant de pénétrer au niveau du conduit auditif interne et rejoindre le canal de Fallop. Quand celui-ci rejoint le canal de Fallop, il va décrire la première portion du nerf facial qui est la portion labyrinthique entre le vestibule et le limaçon et réalisant un genou antérieur avant de se projeter en arrière de façon presque horizontale entre le vestibule et la caisse du tympan.

Et bien sûr, par la suite, devenir presque vertical pour former la portion mastoïdienne du nerf facial après avoir réalisé un coude. Au niveau du ganglion géniculé, le nerf facial va donner des fibres nerveuses du nerf pétreux qui vont rejoindre la glande lacrymale et les fosses nasales tout en étant responsables de la sécrétion lacrymale et la sécrétion des fosses nasales. Et bien entendu, il va donner des fibres nerveuses qui vont rejoindre la corde du tympan pour être responsables après avoir rejoint le nerf lingual de l'innervation sensorielle des deux tiers antérieurs de la langue et bien entendu de la sécrétion des glandes submandibulaires et de la glande sublinguale.

Tous ces éléments sont très importants à connaître sur le plan physiologique parce que sur cela, on va se baser pour pouvoir comprendre le diagnostic topographique des lésions du nerf facial en fonction de l'existence ou de l'absence de l'atteinte de l'une ou de l'autre fonction. Vous avez sur le schéma du bas une vue externe, une coupe externe de la caisse du tympan qui vous montre le trajet de la corde du tympan après sa sortie du nerf facial. C'est une oreille gauche et qui va rejoindre, bien entendu, comme nous l'avons bien expliqué, le nerf lingual.

Pour pouvoir faciliter la compréhension du cours, dans le cadre du diagnostic positif de la paralysie faciale périphérique, nous avons pris comme type de description la paralysie faciale périphérique unilatérale et plus particulièrement la paralysie faciale totale touchant les territoires faciaux supérieurs et inférieurs. La paralysie faciale unilatérale va donner sur le plan clinique une

symptomatologie touchant plus particulièrement la motricité de la face ce qui va donner au repos une asymétrie du visage comme vous le constatez sur cette image qui relate de l'existence d'une paralysie faciale droite avec des traits diviés du côté sein parce que le tonus musculaire du côté sein va tirer la face de son côté. Les rides frontales au niveau du côté atteint sont effacées par rapport au côté opposé.

Il y a une chute du sourcil du côté atteint, un sillon nasogénien qui est effacé parce que le tonus musculaire n'est pas très bien développé et une commussure labiale abaissée. Lorsque le patient fait une respiration assez poussée et soutenue, on voit que sa joue est flasque et il va se soulever lors de l'expiration relatant de l'existence d'une hypotonie au niveau de son hémiphase droite. A la mimique, l'asymétrie du visage va s'accroître.

Il va s'accroître avec une traction plus importante du côté sain par rapport au côté malade. Vous voyez très bien la disparition des rides frontales, l'absence de formation de sillon nasogénien et bien sûr vous voyez la diviation de la fente buccale vers le côté sain. Quand on demande au patient une fermeture palpébrale du côté atteint, on va constater que cette fermeture palpébrale est incomplète d'une part et deuxièmement, le globe oculaire se soulève vers le haut et vers le dehors.

C'est ce qu'on appelle le signe de Characbel et qui relate de l'existence d'une paralysie faciale touchant les territoires supérieurs. Le sujet à la mimique est incapable d'élever la commissure labiale lors du sourire. Tous ces éléments sont très importants à consigner sur le dossier clinique parce qu'ils vont nous permettre d'assurer le suivi du patient qui a une paralysie faciale périphérique.

Lorsqu'on demande au patient d'abaisser sa lèvre inférieure vers le bas, le constat de l'absence de relief du muscle possié du cou du côté paralysé atteste du signe de possié de Babinski relatant de l'existence d'une atteinte des territoires inférieurs de la branche cervicofaciale. Le patient trouve de très grandes difficultés au cours de la mastication du fait de la perte du mouvement jugal dû à la paralysie faciale périphérique. Et le soulèvement des sourcils qui, au cours d'une paralysie faciale périphérique, est absent va être très manifesté, surtout lorsqu'on constate lors de ce soulèvement l'absence de l'apparition des rides frontales.

Après avoir vu la forme de description qui relate d'une paralysie faciale périphérique unilatérale totale, nous allons voir les différentes formes cliniques que l'on pourrait rencontrer en pratique. Tout d'abord, la paralysie faciale frustin. Celle-ci va se manifester par une asymétrie discrète du visage que l'on peut diagnostiquer grâce à la recherche de signes de sillons de soucle et qu'on peut rechercher lorsqu'on demande au patient une fermeture forcée des paupières, comme vous le constatez sur la photo du bas.

Lorsqu'il y a une paralysie faciale fruste, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les sillons du côté paralysé sont beaucoup plus lents que les sillons du côté normal. Et ça relate de l'existence

d'un défaut d'obturation totale de la fonte palpébrale dû à la paralysie faciale périphérique. Les deuxièmes formes cliniques sont les formes bilatérales qui vont être responsables d'une perte totale de la mimique et par conséquent d'une gêne alimentaire importante.

Et dans ce cadre-là, concevez très bien qu'on va avoir un signe de Charlebel bilatéral avec une exposition cornéenne bilatérale. Chez le comateux, le diagnostic de la paralysie faciale périphérique est à rechercher de façon systématique. Par le constat d'un effacement des rides faciales.

Lorsqu'on constate que le sujet a une joue plus flasque que l'autre, c'est ce qu'on appelle le sujet qui fume la pipe. Et lors de l'asymétrie du visage, lors de la manœuvre de Pierre-Marie Foix qui consiste en la compression rétro-angulo-mandibulaire, qui sera responsable d'une douleur importante avec une grimace qui va accentuer l'asymétrie du visage. Quels sont les diagnostics différentiels des paralysies faciales périphériques? Tout d'abord, la paralysie faciale centrale.

Celle-ci est de diagnostic relativement facile lorsqu'on constate qu'il y a une préservation de l'innervation des territoires supérieurs de la face. Le deuxième diagnostic différentiel, c'est les asymétries faciales constitutionnelles, plus particulièrement dans le syndrome automandibulaire où la déformation de la face est due à une anomalie de la charpente plutôt osseuse que neuromusculaire. Le troisième diagnostic différentiel est en rapport avec les myopathies qui sont responsables d'une déplégie faciale et qui sont souvent associées à un ptosis, des troubles de déglutition et de la phonation.

Quel est le bilan clinique et paraclinique à demander devant une paralysie faciale périphérique? Tout d'abord, nous allons voir quels sont les buts de ce bilan clinique et paraclinique. Tout d'abord, ce bilan va permettre de déterminer le siège lésionnel du nerf facial. Nous allons présenter le diagnostic topographique de la paralysie faciale périphérique.

Préciser le pronostic de récupération de la paralysie faciale et le degré exact de l'atteinte nerveuse par une évaluation clinique électrophysiologique. Et enfin, essayer de poser le diagnostic étiologique de la paralysie faciale périphérique. Quels sont maintenant les diagnostics topographiques d'une paralysie faciale périphérique? Le diagnostic topographique d'une paralysie faciale périphérique se base sur des arguments cliniques.

Prenons en considération le contexte clinique de l'apparition de la paralysie faciale, qui peut être d'origine traumatique lors d'un traumatisme crânien, infectieuse et inflammatoire lors d'une otite moyenne chronique, ou tumorale lors d'une pathologie tumorale de la glande parotide. Ces arguments cliniques se basent aussi sur les signes accompagnateurs, qui peuvent relater d'une sémilogie neurologique, faisant évoquer des lésions associées à la paralysie faciale périphérique. Une sémilogie otologique, pouvant rattacher la paralysie faciale périphérique à une pathologie otitique, ou auto-neurologique, à une tumeur parotidienne, expliquant l'origine parotidienne ou la topographie parotidienne de la paralysie faciale périphérique, ou à une lésion

faciale dont la topographie explique une paralysie faciale partielle, ou parfois une paralysie faciale totale.

À côté de ces arguments cliniques, nous avons des arguments paracliniques, qui vont nous permettre de déterminer avec précision le siège de l'atteinte du nerf facial au cours de son trajet en intra-pétreux plus particulièrement, et qui vont rechercher l'atteinte de la fonction de la corde du tympan. Cette atteinte de la fonction de la corde du tympan va être attestée en constatant la diminution de la gustation des deux tiers antérieurs de l'imilangue du côté paralysé, et qui est diagnostiquée par l'électro-gustométrie. Le constat de la diminution de la gustation des deux tiers antérieurs de l'imilangue va attester de l'existence d'une lésion de la septième paire crânienne en amont de la corde du tympan, c'est-à-dire au niveau de tout le nerf facial qui existe en amont de l'émergence de la corde du tympan.

L'atteinte de la fonction du nerf du muscle de l'étrier La recherche des réflexes tapédiens et le constat de leur abolition au cours d'une paralysie faciale va attester de l'existence d'une lésion de la septième paire crânienne en amont du nerf du muscle de l'étrier, donc au niveau du nerf facial en amont de l'émergence du nerf de l'étrier. Donc c'est plus au niveau du coude ou au niveau de la portion tympanique ou de la portion bien sûr labyrinthique. Des arguments paracliniques attestant de l'atteinte d'une aire grand-pétreuse superficielle qui émerge du gonglion géniculé et qui sera attesté par le constat de la diminution de la sécrétion lacrymale diagnostiquée par le test de Schirmer.

Quand on constate au cours d'une paralysie faciale périphérique une diminution de la sécrétion lacrymale au cours du test de Schirmer, ceci veut dire qu'il y a une lésion du nerf facial de topographie siégeant en amont du gonglion géniculé. Avant l'émergence des nerfs pétreux et donc au niveau de la première portion du nerf facial au niveau de la portion labyrinthique. D'autres arguments paracliniques peuvent aider au diagnostic topographique de l'atteinte du nerf facial.

Ce sont des arguments radiologiques basés sur la tomодensitométrie qui va montrer l'atteinte lésionnelle au niveau du nerf facial et au niveau de quelle portion de celui-ci ou la résonance magnétique nucléaire au niveau, bien sûr, plus particulièrement basicranien ou au niveau des différents segments du nerf facial. Après avoir vu le diagnostic topographique, on va voir le diagnostic de gravité qui va nous permettre de poser un pronostic de la paralysie faciale périphérique. Ce diagnostic de gravité va se baser tout d'abord sur le testing facial.

Celui-ci comprend deux parties, une évaluation de la motricité et une deuxième partie qui se consacrera à l'évaluation des tonus. L'évaluation en testing musculaire de la motricité s'intéresse à l'évaluation clinique avec une cotation à prétexte de 10 groupes musculaires faciaux et selon une échelle allant de 0 à 3. 0 étant la notation lorsqu'on n'a aucun mouvement au niveau de la face et 3 lorsqu'on a une motricité tout à fait normale. Le score total en relation avec les deux groupes musculaires va nous permettre d'avoir une note sur 30 et qui peut ainsi être relevée tous

les jours pour pouvoir évaluer la récupération ou l'aggravation de la paralysie faciale.

La deuxième partie de ce testing facial sera consacrée à l'évaluation des tonus et qui va apprécier de façon globale celui-ci entre l'hémiphase paralysé et l'hémiphase non paralysé. D'autres moyens vont permettre de faire ce diagnostic de gravité que ce sont des moyens électrophysiologiques. Ces moyens électrophysiologiques vont se baser essentiellement sur l'électromyographie de détection c'est-à-dire l'EMG qui a un intérêt plus dans la surveillance de la récupération à moyen et à long terme parce qu'il va nous attester du pourcentage des fibres nerveuses fonctionnelles au niveau du nerf facial. Le deuxième moyen électrophysiologique est l'électroneurographie ou test d'ESLEN qui va recueillir un potentiel d'action musculaire après stimulation du nerf facial au voisinage du trou stylo-mastoïdien.

C'est un examen qui doit être réalisé avant le dixième jour par rapport au début de la paralysie faciale périphérique pour avoir une signification et mesure le pourcentage des fibres dégénérées. Il a, dans le cadre de cette évaluation de gravité, une valeur pronostique. Quels sont maintenant les diagnostics étiologiques des paralysies faciales périphériques ? Les diagnostics étiologiques de la paralysie faciale périphérique vont pouvoir être posés en se basant sur les circonstances d'installation de la paralysie faciale périphérique, sur la localisation de la lésion, c'est-à-dire le diagnostic topographique comme nous l'avons vu qui va se baser sur la clinique mais aussi sur un certain nombre de données paracliniques et sur des examens complémentaires qui seront demandés en fonction de la situation clinique.

Ils peuvent être des examens d'évaluation de l'audition tel que l'audiométrie ou des examens radiologiques tel que la tomodensitométrie ou la résonance magnétique nucléaire. On va commencer par la pathologie pas la plus fréquente mais la plus grave à laquelle il faut penser en premier lieu en termes de paralysie faciale périphérique et qui sont les paralysies faciales périphériques d'origine tumorale. Ce sont des paralysies d'installation progressive sans tendance à la récupération qui peuvent être secondaires à des lésions tumorales soit bénignes ou malignes de la glande parotide soit à des schwannomes de la septième ou de la huitième paire crânienne soit à des métastases osseuses siégeant au niveau de la pyramide pétreuse du rocher soit à des méningiomes de l'ongle pentocérébelleux ou à des tumeurs du glomus jégulaire.

Le traitement de la paralysie faciale périphérique va se baser sur le traitement de la lésion bien sûr avec une prise en charge particulière sur le plan nerveux du nerf facial. Vous avez sur l'image IRM en coupe axiale et puis en coupe frontale une image d'une lésion de l'ongle pentocérébelleux qui est un neurone de l'acoustique et qui se manifeste en plus de la surdité par une paralysie faciale périphérique. Vous voyez cette lésion en coupe et qui pourrait être diagnostiquée à l'occasion d'une paralysie faciale périphérique isolée.

La paralysie faciale traumatique c'est le deuxième groupe étiologique des paralysies faciales périphériques. Ils peuvent être secondaires à des fractures du rocher lors d'un traumatisme crânien comme nous l'avons vu le nerf facial a un trajet assez lent au niveau de la pyramide

pétreuse des traumatismes opératoires lors de la chirurgie de l'oreille moyenne des traumatismes opératoires dans la chirurgie du neurone de l'acoustique sachant que le nerf cochléaire a un rapport intime avec le nerf facial et dont la dissection risquerait de mettre à risque le nerf facial ou des plaies de la région parotidienne comme vous voyez sur ce schéma là et qui peuvent soit toucher le tronc du nerf facial ou l'une de ses branches. Sur cette photo d'un scanner de la pyramide pétreuse en coupe axial vous voyez ici la région mastoïdienne, les cellules mastoïdiennes ici vous avez le sinus latéral et puis à ce niveau là l'oreille interne avec le conduit auditif interne et vous voyez le trait de fracture au cours d'une fracture du rocher qui passe au travers de la cochlée et qui touche le nerf facial étant à ce moment là responsable d'une paralysie faciale lors de ces fractures dites fractures transversales de la pyramide pétreuse.

Troisième groupe des étiologies des paralysies faciales périphériques sont représentées par les paralysies faciales d'origine otitique qui sont les otites moyennes aiguës que nous avons vu dans un chapitre antérieur au cours desquels l'otite moyenne aiguë surtout au stade collecté peut être à l'origine d'une paralysie faciale périphérique et les otites moyennes chroniques plus particulièrement les otites moyennes chroniques cholestéatomateuses qui sont réputées par leur profil destructeur par rapport à l'os et qui peut aller toucher le nerf facial dans son canal de fallop. Nous allons parler maintenant de la paralysie faciale périphérique la plus fréquente et qui doit rester toujours un diagnostic d'élimination qui est la paralysie faciale à frigoris qu'on appelle aussi l'essentiel ou l'idiopathique ou la maladie de Bell. C'est la paralysie faciale périphérique la plus fréquente.

Son incidence est de 11 à 23 pour 100 000 personnes. Il réalise une polynévrite due à l'herpès simplex virus. Sur le plan clinique, il va se manifester par une paralysie faciale totale d'apparition brutale avec des notions de prodromes viraux débutant avant l'apparition de la paralysie faciale.

A la phase initiale, le patient va décrire des douleurs faciales rétro-auriculaires, des troubles du goût, une hyperacousie, une sécheresse oculaire avant l'apparition du tableau clinique de la paralysie faciale totale unilatérale que nous avons décrit au début dans le diagnostic positif. Dans ce cadre-là, l'otoscopie est tout à fait normale et le patient ne présente pas de surdité, ni vertiges, ni aucun autre symptôme. Le bilan paraclinique, si il est demandé à visée étiologique, est totalement négatif.

L'audiométrie ne montre pas de surdité, la tomodensitométrie, la résonance magnétique nucléaire ne trouve pas de lésions tumorales, ni de lésions inflammatoires évolutives au niveau de la caisse du tympan ou au niveau de l'oreille interne. Le traitement de la paralysie faciale à frigoris est un traitement qui va se baser essentiellement sur une corticothérapie de courte durée, l'usage de vasodilatateurs et l'usage des antiviraux qui sont utilisés par un certain nombre d'auteurs dans la littérature visant essentiellement l'herpès virus simplex. Des soins oculaires sont à faire de façon systématique pour éviter la kératite et une kinésithérapie faciale précoce et prolongée pour amener la face à récupérer plus facilement sa fonction motrice lors de la disparition de la paralysie faciale.

Un certain nombre d'étiologies beaucoup moins fréquentes sont à évoquer et à rechercher telles que la paralysie faciale zoostérienne qui est due à une réactivation du virus de zona au niveau du ganglion géniculé et qu'on va diagnostiquer à l'occasion d'une paralysie faciale périphérique associée à une éruption visiculaire dans la zone de Ramsey Hind. La zone du conduit avec l'apparition des visicules au niveau de l'entrée du conduit auditif externe et bien sûr à l'intérieur du conduit auditif externe. Avec une surdité de perception et ou vertige dans plus de 40% des cas et ce qu'il faut savoir en termes de paralysie faciale zoostérienne c'est que la paralysie faciale est de mauvais pronostic en comparaison avec la paralysie faciale africorée.

Le traitement associe obligatoirement l'usage des antiviraux et à une corticothérapie de courte durée. La maladie de Lyme est une méningo-radiculite causée par une spiroquette qui est due à une piqûre de tiques remontant le plus souvent entre 3 et 6 mois avant l'apparition de la paralysie faciale périphérique et qui va être évoquée sur une clinique très évocatrice révélant un érythème migrant de même que l'apparition de névralgie ou de méralgie associée à la paralysie faciale. La maladie de Lyme est de diagnostic sérologique bien sûr en réalisant une sérologie spécifique de cette maladie et bien sûr le traitement a reposé sur une antibiothérapie qui pourrait utiliser l'une des familles suivantes soit la moxyciline soit une cycline ou lorsqu'il y a une allergie ou plus particulièrement chez l'enfant on peut faire appel à l'usage de macrolides.

Le syndrome de Melkerson-Ressenthal est une étiologie relativement rare de la paralysie faciale périphérique mais c'est une étiologie à évoquer devant une paralysie faciale récidivante. Chez un patient qui a un certain nombre de signes cliniques évocateurs à savoir une langue fissurée et une keylite avec un œdème facial labial et périorbitaire. Il faut savoir que l'éthiopathogénie de la paralysie faciale périphérique dans ce cadre là dans le cadre du syndrome de Melkerson-Ressenthal reste toujours inconnue.

D'autres étiologies peuvent être responsables de paralysie faciale périphérique qui peuvent être des étiologies d'origine virale telles que le VIH l'Epstein-Barr virus ou le cytomégalovirus origines bactériennes telles que la lèpre, la tuberculose, la maladie du griffe de chat, le tétanos et la syphilis pour dire que plusieurs étiologies peuvent être évoquées devant une paralysie faciale. Nous terminons en parlant des paralysies faciales de l'enfant pas parce qu'ils sont moins fréquentes mais parce qu'ils sont assez particulières sur le plan étiologique. Ils peuvent être secondaires à des paralysies congénitales dues à des malformations congénitales du nerf facial telles que les agénies du nerf facial par exemple à des paralysies faciales acquises prénatales et périnatales dues soit à la mauvaise utilisation des forceps au cours de l'accouchement ou à un traumatisme par compression sur les parois osseuses du pelvis de la maman.

Les paralysies faciales acquises post-natales s'enduent le plus souvent à des étiologies comparables à celles des étiologies de l'adulte. L'évolution des paralysies faciales périphériques est variable en fonction de l'étiologie elles seraient bonnes dans la paralysie faciale affrégorée. Quelles sont maintenant les complications des paralysies faciales périphériques ? Ces

complications sont essentiellement oculaires à type d'extropions paralytiques de la paupière inférieure une kératite et c'est la raison pour laquelle les soins oculaires sont obligatoires au cours du traitement de la paralysie faciale par des larmes artificielles et une occlusion palpébrale nocturne et comme autres complications qu'on peut avoir au cours d'une paralysie faciale c'est les larmes de crocodile qui sont déclenchées par l'alimentation.

En dehors des complications oculopalpébrales nous allons parler des complications mécaniques de la paralysie faciale périphérique. Ces complications mécaniques de la paralysie faciale périphérique peuvent se voir à type d'hémispasme facial post-paralytique ou de syncynysie faciale. Ces syncynysies faciales réalisent des mouvements involontaires d'une région de la face lors des mouvements volontaires d'une autre région faciale.

En conclusion, nous disons que le diagnostic de la paralysie faciale périphérique reste clinique basé sur les connaissances de l'anatomie de la physiologie du nerf facial qui sont indispensables pour expliquer la diversité des tableaux cliniques. Le bilan clinique et paraclinique faisant appel à des moyens électrophysiologiques et à l'imagerie par TDM ou IRM vont permettre le diagnostic topographique mais aussi l'évaluation de la gravité de la paralysie faciale périphérique. Sur le plan du diagnostic étiologique, le diagnostic de la paralysie faciale a frégéré même s'il est le plus fréquent doit rester un diagnostic d'élimination à rechercher après avoir éliminé toute étiologie d'origine tumorale, traumatique ou infectieuse.

Je vous remercie.